Cervicovaginitis · Guía práctica integral para la ECOE

Estación de consulta con caso clínico · Primer y segundo nivel de atención

Siglas de uso frecuente. VB: vaginosis bacteriana. CVV: candidosis vulvovaginal. ITS: infección de transmisión sexual. KOH: hidróxido de potasio. NAAT: prueba de amplificación de ácidos nucleicos. VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. VPH: virus del papiloma humano. RPM: rotura prematura de membranas. FUM: fecha de la última menstruación. FPP: fecha probable de parto. SDG: semanas de gestación. AGO: antecedentes ginecoobstétricos. IVSA: inicio de la vida sexual activa. MPF: método de planificación familiar. CDC: Centers for Disease Control and Prevention. GPC: guía de práctica clínica. NOM-007: NOM-007-SSA2-2016.

Índice

1 La estación y su rúbrica
- 1.1 Criterios que se califican
- 1.2 Cómo usar esta guía
- 1.3 Secuencia de la consulta

2 Interrogatorio
- 2.1 Presentación y ficha
- 2.2 Antecedentes
- 2.3 Fecha probable de parto y edad gestacional
- 2.4 Padecimiento actual
- 2.5 Signos vitales, somatometría y glucosa capilar

3 Exploración física
- 3.1 Preparación y exploración general
- 3.2 Especuloscopia y toma de muestras
- 3.3 Descripción según la causa

4 Fundamentos, agentes y diferencial
- 4.1 Flora normal y agentes
- 4.2 Diagnóstico diferencial
- 4.3 Factores de riesgo

5 Pruebas diagnósticas

6 Tratamiento según la causa
- 6.1 Tabla de tratamiento
- 6.2 Vaginosis bacteriana
- 6.3 Tricomoniasis
- 6.4 Candidosis vulvovaginal
- 6.5 Bacterias gramnegativas y cervicitis

7 El diagnóstico de la rúbrica

8 Complicaciones e ITS relacionadas

9 Consejería y referencia

10 La consulta prenatal en la estación
- 10.1 Estudios
- 10.2 Ecografías e indicaciones

11 Casos clínicos para practicar

12 Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

13 Diferencias entre fuentes

14 Plan de estudio de dos días

Referencias

1. La estación y su rúbrica

1.1 Criterios que se califican

La práctica 4 de la ECOE parte de una embarazada de 22 semanas con flujo vaginal y califica 16 criterios, cada uno como cumplido o no cumplido; se acredita con 12.[1] No hay criterio eliminatorio, pero varios exigen la respuesta completa: el cálculo obstétrico, los signos vitales con glucosa capilar, la exploración en orden, el exudado vaginal entre los estudios, las tres ecografías y las dosis.

Tabla 1. Criterios de la práctica 4 y respuesta esperada.[1]

#	Criterio	Respuesta o acción esperada	Sección
1	Presentación y ficha de identificación	Saludar, presentarse por nombre y cargo, confirmar la identidad y completar la ficha	2.1
2	Antecedentes completos y cálculo obstétrico	AHF, APNP, APP y AGO (menarca, ritmo, gestas, partos, abortos, cesáreas y óbitos, IVSA, MPF, último Papanicolaou y última mastografía); con FUM del 01/06/2023, FPP del 07/03/2024 y edad gestacional de 22.5 SDG	2.2 y 2.3
3	Signos vitales, talla, peso y glucosa capilar	Pedir todos	2.5
4	Padecimiento actual	Datos de alarma; características del flujo (tiempo de evolución, color y olor); disuria, dispareunia y prurito vaginal	2.4
5	Exploración física	Autorización, bata y exploración cefalocaudal en orden	3
6	Especuloscopia y descripción del cuello	Explicar el procedimiento y describir un cuello en fresa con flujo espumoso	3.2 y 3.3
7	Factores de riesgo (al menos tres)	Duchas vaginales, ropa interior de lycra, múltiples parejas sexuales, higiene inadecuada, alto consumo de alimentos ricos en levaduras, no usar preservativo, coito más de 3 veces por semana	4.3
8	Estudios de laboratorio	Biometría hemática, química sanguínea, grupo y Rh, examen general de orina, **exudado vaginal**, urocultivo, VDRL, VIH, curva de tolerancia a la glucosa y proteinuria con tira reactiva	10.1
9	Agentes causales	*Trichomonas*, *Candida albicans*, bacterias gramnegativas y *Gardnerella vaginalis*	4.1
10	Ecografías	11 a 13,6 semanas (aneuploidías, edad gestacional, número de fetos); 18 a 22 semanas (estructural); tercer trimestre (inserción placentaria, peso fetal estimado y líquido amniótico)	10.2
11	Diagnóstico	Cervicovaginitis por tricomonas	7

#	Criterio	Respuesta o acción esperada	Sección
12	Tratamiento con dosis	Metronidazol en tabletas vaginales, una cada 24 horas durante 10 noches, con tratamiento de la pareja	7 y 12
13	Tratamiento de la candidosis (pregunta directa)	Miconazol en crema vaginal cada 12 horas durante 7 días; nistatina, un óvulo o tableta vaginal al día durante 7 días	6.2 y 6.3
14	Tratamiento de las bacterias gramnegativas	Nitrofurazona, un óvulo vaginal cada 12 a 24 horas durante 10 a 15 días	6.4
15	Complicaciones en el embarazo (al menos tres)	Amenaza de aborto, aborto, amenaza de parto pretérmino, RPM y enfermedad inflamatoria pélvica	8
16	ITS relacionadas	VPH y VIH	8

1.2 Cómo usar esta guía

La rúbrica se construyó sobre una tricomoniasis en el embarazo, pero el mismo formato puede presentar cualquier otra causa de flujo: una VB, una CVV, una cervicitis por *Chlamydia* o gonococo o una mujer no embarazada. Cambian el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento; no cambian la consulta ni la exploración. Las tablas 2 y 3 reúnen lo que distingue y lo que se indica en cada causa, y los nueve casos de la sección 11 las recorren. Tres respuestas de la rúbrica ya no son las vigentes (metronidazol vaginal, nistatina de 7 días y nitrofurazona); la sección 12 muestra cómo decirlas.

1.3 Secuencia de la consulta

1. Higiene de manos, saludo, presentación, identidad y ficha.
2. Antecedentes con historia sexual; si está embarazada, FPP y edad gestacional en voz alta.
3. Signos vitales, peso, talla y glucosa capilar.
4. Padecimiento actual y datos de alarma.
5. Exploración cefalocaudal y, al final, la ginecológica con especuloscopia, toma de muestras y tacto bimanual.
6. Pruebas de consultorio: pH, aminas y examen en fresco.
7. Factores de riesgo, agentes, diferencial y diagnóstico.
8. Estudios; en la embarazada, los del control prenatal y las ecografías.
9. Tratamiento, pareja, consejería, datos de alarma y referencia.[1]

2. Interrogatorio

2.1 Presentación y ficha

Se saluda por su nombre a la paciente, se dice el propio nombre y cargo, se explica que habrá preguntas y una exploración, y se obtiene la ficha: nombre, edad, estado civil, escolaridad, ocupación, residencia y teléfono.[1] En la embarazada, la edad menor de 16 o mayor de 35 años es un factor de riesgo.[2]

2.2 Antecedentes

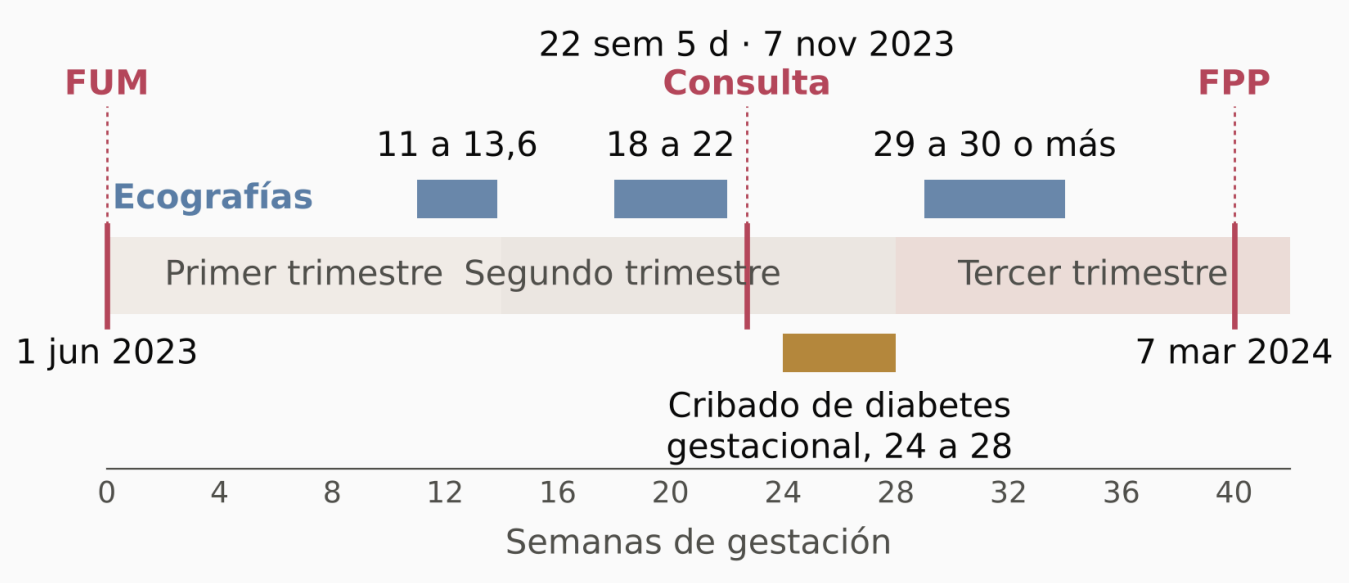
Cada antecedente se pregunta por un motivo:[1,2,3,4]

- **Heredofamiliares:** diabetes (riesgo de diabetes gestacional), hipertensión y malformaciones.
- **No patológicos:** tabaquismo y duchas vaginales (VB), tipo de ropa interior e higiene genital.
- **Patológicos:** diabetes, VIH o inmunodepresión, antibióticos o corticoides recientes (CVV), ITS previas y alergia a metronidazol, clindamicina o azoles.
- **Menarca, ritmo y FUM:** un ciclo regular hace confiable la FUM para calcular la FPP.
- **Gestas, partos, abortos, cesáreas y óbitos:** un parto pretérmino o una RPM previos refuerzan la indicación de tratar la VB sintomática con metronidazol oral.
- **IVSA, parejas, pareja nueva y preservativo:** estiman el riesgo de tricomoniasis, cervicitis y VB.
- **MPF:** los azoles tópicos pueden dañar los condones de látex.
- **Vaginitis previas:** cuatro o más episodios de CVV al año definen la recurrente; una tricomoniasis recurrente obliga a buscar VIH.
- **Último Papanicolaou y última mastografía:** fecha y resultado.
- **Cuerpos extraños:** un tampón o un condón retenidos causan flujo fétido.

2.3 Fecha probable de parto y edad gestacional

Regla de Naegele: al primer día de la FUM se suman 7 días, se restan 3 meses y se suma 1 año; equivale a 280 días.[5] Con la FUM de la rúbrica (1 de junio de 2023), Naegele da el 8 de marzo de 2024 y el conteo de 280 días, el 7 de marzo, porque entre ambas fechas está el 29 de febrero. La rúbrica registra el 7 de marzo; se dice: “FPP del 7 de marzo de 2024 contando 280 días; por Naegele sería el 8, por el año bisiesto”.[1,5]

Edad gestacional: los días desde la FUM entre 7; el cociente son las semanas y el residuo, los días. **22.5 SDG son 22 semanas y 5 días** (159 días), es decir, una consulta el 7 de noviembre de 2023.[5]



Esquema generado de la línea de tiempo del caso de la rúbrica: FUM el 1 de junio de 2023, consulta a las 22 semanas y 5 días y FPP a los 280 días. Arriba, los periodos de las tres ecografías de la NOM-007; abajo, el cribado de diabetes gestacional entre las semanas 24 y 28. No reproduce un caso real.[2,6]

2.4 Padecimiento actual

Se preguntan el tiempo de evolución y los tratamientos previos, la cantidad, consistencia, color y olor del flujo, el prurito, la disuria, la dispareunia, el dolor pélvico y el sangrado. Los síntomas por sí solos no distinguen las causas, pero orientan (tabla 2): la disuria obliga a descartar una infección urinaria y el dolor pélvico con fiebre, una enfermedad inflamatoria pélvica.[3,4]

Datos de alarma en la embarazada: salida de líquido o sangre por la vagina (RPM o hemorragia), contracciones antes de la semana 37, disminución de los movimientos fetales, fiebre con dolor abdominal y datos de preeclampsia (cefalea, alteraciones visuales, epigastralgia o edema no solo maleolar).[2,6]

2.5 Signos vitales, somatometría y glucosa capilar

Se piden la presión arterial, las frecuencias cardiaca y respiratoria, la temperatura, el peso, la talla y la glucosa capilar; omitir uno cuesta el criterio.[1] La fiebre no es propia de una vaginitis y obliga a buscar una complicación; la hiperglucemia favorece la CVV; y después de la semana 20 una presión de 140/90 mmHg o más obliga a buscar preeclampsia.[2,4]

3. Exploración física

3.1 Preparación y exploración general

Se pide autorización, se explica el procedimiento, se ofrece una bata, se asegura la privacidad y la paciente puede estar acompañada; quien explora se lava las manos y usa guantes. La rúbrica no da el punto si falta un paso o si la exploración se hace en desorden.[1,7] La exploración va de la cabeza a los pies: estado general, conjuntivas, boca, cardiopulmonar, mamas, abdomen y extremidades. En la embarazada se añaden la altura del fondo uterino (a las 22 semanas, a nivel del ombligo), la frecuencia cardiaca fetal (110 a 160 por minuto) y las contracciones. La exploración ginecológica se deja al final.[2,6]

3.2 Especuloscopia y toma de muestras

Se inspeccionan los genitales externos en busca de eritema, edema, fisuras, rascado o lesiones satélite. La especuloscopia se explica paso a paso:[3,7]

1. Espejo de Graves del tamaño adecuado, **sin lubricante** si se van a tomar muestras (se humedece con solución fisiológica).
2. Se introduce cerrado, con un ángulo de 45 a 90° respecto del piso vaginal, mientras la paciente puja.
3. En el tercio medio se gira a la horizontal y se abren las valvas hasta exponer el cuello sin lastimarlo.
4. Se inspeccionan las paredes, la secreción (cantidad, color, consistencia y olor) y el cuello.
5. Se toman las muestras: **pH** de la pared lateral de la vagina; **exudado** de las paredes para examen en fresco con solución salina y con KOH al 10% y para Gram y cultivo; muestra **endocervical** para NAAT si hay cervicitis o riesgo de ITS; y citología si corresponde por calendario.[3,8]
6. Se retira cerrándolo lentamente mientras se revisan las paredes.

En la embarazada se comprueba que el orificio esté cerrado y que no salga líquido amniótico. Después se hace el **tacto bimanual**: el dolor a la movilización del cuello, uterino o anexial ante una cervicitis indica enfermedad inflamatoria pélvica.[2,8]

3.3 Descripción según la causa

Se describe en orden fijo: vulva, paredes, secreción, cuello y orificio.[3,4,8]

- **VB:** “Vulva normal; paredes sin inflamación, cubiertas por secreción fluida, homogénea, blanco-grisácea, con olor a pescado; cérvix sin alteraciones.”
- **CVV:** “Vulva con eritema, edema, fisuras y lesiones satélite; secreción blanca, espesa y grumosa, adherida, sin mal olor; cérvix sin alteraciones.”

- **Tricomoniasis (rúbrica):** “Vulva y paredes eritematosas con flujo abundante, amarillo-verdoso, espumoso y fétido; cérvix con puntilleo hemorrágico, en fresa.”
- **Cervicitis:** “Paredes normales; exudado endocervical mucopurulento; cérvix friable, que sangra al pasar el hisopo.”
- **En la embarazada** se añade: “orificio cervical cerrado, sin sangrado ni salida de líquido”.

4. Fundamentos, agentes y diferencial

4.1 Flora normal y agentes

Los **lactobacilos** mantienen un pH vaginal de **3,5 a 4,5**. La secreción fisiológica varía con el ciclo y no se trata; del 10 al 15% de las mujeres sin síntomas están colonizadas por *Candida*, que tampoco se trata.[3,4] La VB es la causa más frecuente de vaginitis infecciosa y la CVV, la segunda.[3] Los agentes son:[1,3,4,8,9]

- **VB:** anaerobios que sustituyen a los lactobacilos, sobre todo *Gardnerella vaginalis*.
- **CVV:** *Candida albicans* (85 a 95%) y otras especies, como *C. glabrata*.
- **Tricomoniasis:** *Trichomonas vaginalis*, de transmisión sexual.
- **Cervicitis:** *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae*.
- **Bacterias gramnegativas:** flora aerobia intestinal, como *Escherichia coli*, que define la vaginitis aeróbica.

4.2 Diagnóstico diferencial

Tabla 2. Diferencial de las causas infecciosas de flujo.[3,4,8,10]

Dato	VB	CVV	Tricomoniasis	Cervicitis
Flujo	Fluido, homogéneo, blanco-grisáceo, olor a pescado	Blanco, espeso, grumoso, adherente, sin olor	Abundante, amarillo-verdoso, espumoso, fétido	Mucopurulento desde el cuello
Síntomas	Solo flujo y olor	Prurito, ardor, disuria, dispareunia	Disuria, dispareunia, dolor pélvico	A menudo asintomática; disuria, sangrado poscoital
Signos	Sin inflamación	Eritema, edema, fisuras, lesiones satélite	Vaginitis intensa, cuello en fresa	Cuello friable que sangra al hisopo
pH	Mayor de 4,5	Normal	Habitualmente mayor de 4,5	Variable
Microscopía	Células clave; aminas positivas	Levaduras, hifas o pseudohifas con KOH	Tricomonas móviles (sensibilidad de 60%)	Se diagnostica con NAAT
Pareja	No se trata de rutina	No se trata	Se trata siempre	Se trata siempre

Criterios de Amsel para la VB: al menos tres de flujo fino y homogéneo, células clave en más del 20% de las células epiteliales, pH mayor de 4,5 y prueba de aminas positiva. La tinción de Gram es la referencia.[8,10]

Se descartan además la secreción fisiológica, el cuerpo extraño y, en la embarazada, la RPM (salida de líquido por el orificio, que se refiere de inmediato) y la infección urinaria (examen general de orina y urocultivo). Las infecciones pueden coexistir: un pH mayor de 4,5 con levaduras obliga a buscar VB o tricomonas, y una tricomoniasis obliga a buscar otras ITS.[2,3]

4.3 Factores de riesgo

La rúbrica acepta tres de su lista.[1] Se dicen primero los que tienen respaldo: **duchas vaginales** (VB), **múltiples parejas o pareja nueva** (tricomoniasis, cervicitis y VB) y **no usar preservativo** (tricomoniasis y cervicitis). Se añade el que corresponda al caso: tabaquismo (VB); embarazo, diabetes mal controlada, inmunodepresión, corticoides y antibióticos (CVV). La ropa de lycra y el coito frecuente se atribuyen a la CVV con evidencia contradictoria, y la higiene inadecuada y los alimentos con levaduras no están cuantificados en las guías revisadas.[3,4,11,12]

5. Pruebas diagnósticas

En la consulta se hacen el pH, la prueba de aminas (KOH sobre la secreción: olor a pescado en la VB) y el examen en fresco con solución salina (células clave y tricomonas) y con KOH (hongos). En las formas leves basta el pH; en las moderadas o graves se pide microscopía. Sin microscopía, la forma no complicada puede tratarse de forma empírica con vigilancia de la respuesta.[3,4] En el laboratorio, el Gram es la referencia de la VB, el cultivo identifica la especie de *Candida* (indispensable en la CVV complicada y recurrente) y la NAAT en muestra vaginal, endocervical u orina es de elección para tricomonas, *Chlamydia* y gonococo. Ante una ITS se piden además sífilis y VIH.[3,4,8]

6. Tratamiento según la causa

6.1 Tabla de tratamiento

Tabla 3. Tratamiento de primera línea fuera y dentro del embarazo.[2,3,4,8,13]

Causa	Fuera del embarazo	En el embarazo	Pareja
VB	Metronidazol 500 mg oral cada 12 h por 7 días; o gel al 0,75% intravaginal 5 días; o clindamicina en crema al 2% 7 días	Solo si es sintomática: metronidazol oral 7 días (250 mg cada 8 h según la GPC o 500 mg cada 12 h según los CDC); con alergia, clindamicina 7 días	No de rutina
Tricomoniasis	Metronidazol 500 mg oral cada 12 h por 7 días; alternativa, tinidazol o secnidazol 2 g dosis única	Metronidazol 500 mg oral cada 12 h por 7 días, en cualquier trimestre	Siempre: metronidazol 2 g dosis única al varón; abstinencia hasta terminar
CVV no complicada	Fluconazol 150 mg oral dosis única; o azol vaginal (clotrimazol, miconazol, isoconazol)	Es complicada: azol vaginal 7 días (clotrimazol al 1% o miconazol al 2%, 5 g al día) o nistatina 14 días; sin fluconazol oral	No se trata
Chlamydia	Doxiciclina 100 mg cada 12 h por 7 días; alternativa, azitromicina 1 g dosis única	Azitromicina 1 g dosis única; alternativa, amoxicilina 500 mg cada 8 h por 7 días	Siempre
Gonococo	Ceftriaxona 500 mg intramuscular dosis única (1 g con 150 kg o más)	Igual	Siempre

6.2 Vaginosis bacteriana

Fuera del embarazo se tratan las mujeres sintomáticas y las que van a operarse; se evita el alcohol durante el metronidazol. En el embarazo se trata la VB **sintomática**, porque se asocia con aborto, parto pretérmino, RPM y endometritis; la asintomática no se busca ni se trata de rutina, porque tratarla no reduce el parto pretérmino. El metronidazol es seguro en cualquier trimestre.[3,8,14,15] La GPC de 2014 sugiere cambiar el DIU en la mujer con VB, pero las demás guías no lo indican y no justifica retirarlo.[3]

6.3 Tricomoniasis

El tratamiento es **sistémico**, porque el metronidazol vaginal no alcanza la uretra ni las glándulas perivaginales; el esquema de 7 días reduce a la mitad la persistencia frente a la dosis única de 2 g. Se trata a la pareja, se indica abstinencia hasta que ambos terminen y estén sin síntomas, y después preservativo; se evita el alcohol. Se revalora en menos de 3 meses, porque la reinfección llega al 17%, y una tricomoniasis recurrente obliga a buscar VIH.[3,8] El diagnóstico completo de la rúbrica es: “Embarazo de 22 semanas y 5 días con cervicovaginitis por *Trichomonas vaginalis*”.[1]

6.4 Candidosis vulvovaginal

Clasificación: no complicada (menos de 4 episodios al año, leve o moderada, probablemente *C. albicans*, mujer inmunocompetente); complicada (grave, recurrente, especie distinta de *C. albicans*, diabetes, inmunodepresión o **embarazo**); y recurrente (4 o más episodios documentados en un año).[4]

- **No complicada:** los azoles curan al 80 a 90%, sin diferencias entre vía oral y vaginal ni entre esquemas cortos y largos; los tópicos son más eficaces que la nistatina (100 000 UI al día durante 14 días).[4]
- **Grave:** fluconazol 150 mg con una segunda dosis a las 72 horas.[4]
- **Con diabetes, VIH o corticoides:** se controla la enfermedad y se evitan los esquemas cortos (nistatina 14 días o fluconazol cada tercer día por tres dosis).[4]
- **Recurrente:** cultivo para identificar la especie, inducción (tópico 7 a 14 días o fluconazol cada tercer día por tres dosis) y mantenimiento con fluconazol semanal durante 6 meses. Con *C. glabrata*, que no responde a los azoles, nistatina 21 días.[4]
- **Embarazo:** solo azoles tópicos 7 días o nistatina 14 días (opción institucional del IMSS); el fluconazol oral se asocia con aborto y malformaciones. La colonizada sin síntomas no se trata.[4,16]

No se ha demostrado transmisión sexual: no se trata a la pareja ni se exige abstinencia.[4] Se refieren al segundo nivel la CVV sin respuesta, la complicada sin laboratorio y la mujer con VIH; a infectología, la recurrente sin posibilidad de identificar la especie.[3,4]

6.5 Bacterias gramnegativas y cervicitis

Las “bacterias gramnegativas” de la rúbrica corresponden a la **vaginitis aeróbica**, una alteración de la flora con inflamación distinta de la VB, asociada en el embarazo con parto pretérmino y RPM; su tratamiento no figura en las guías del IMSS ni de los CDC. La rúbrica califica la nitrofurazona en óvulos cada 12 a 24 horas durante 10 a 15 días.[1,9,17]

La **cervicitis** se reconoce por exudado endocervical mucopurulento o sangrado fácil; la clamidia es asintomática en alrededor del 75% de las mujeres. Se trata a la pareja; en la embarazada con clamidia se comprueba la curación a las 3 o 4 semanas, y en ambas infecciones se repite la prueba a los 3 meses. En el embarazo se busca la clamidia en las menores de 25 años y en las mayores con factores de riesgo.[3,8,14]

7. El diagnóstico de la rúbrica

En el caso de la rúbrica, el flujo amarillo-verdoso, espumoso y fétido, el cuello en fresa, el pH mayor de 4,5 y las tricomonas móviles dan el diagnóstico de **cervicovaginitis por *Trichomonas vaginalis*** en un embarazo de 22 semanas y 5 días. Se trata con metronidazol oral 7 días y a la pareja con 2 g en dosis única; la sección 12 indica cómo mencionar el esquema vaginal de la rúbrica.[1,2,8]

8. Complicaciones e ITS relacionadas

La rúbrica pide al menos tres complicaciones en el embarazo: amenaza de aborto, aborto, amenaza de parto pretérmino, RPM y enfermedad inflamatoria pélvica.[1] La VB se asocia con aborto, parto pretérmino, RPM y endometritis; la tricomoniasis, con parto pretérmino, RPM y bajo peso al nacer; y la cervicitis, con enfermedad inflamatoria pélvica e infertilidad.[2,3]

Las ITS relacionadas que pide la rúbrica son **VPH y VIH**: la tricomoniasis aumentó alrededor de 1,5 veces la adquisición del VIH en un metaanálisis, y la VB se asoció con infección por VPH y con neoplasia intraepitelial cervical. En la consulta se ofrecen las pruebas de VIH y sífilis y se revisa el último Papanicolaou.[1,18,19]

9. Consejería y referencia

- **VB:** evitar duchas vaginales y tabaco; volver si recurre.[3]
- **CVV:** ropa holgada, control de la glucosa y no autotratarse si recurre.[4]
- **Tricomoniasis y cervicitis:** tratamiento simultáneo de la pareja, abstinencia hasta terminar, preservativo y pruebas de otras ITS.[3,8]
- **Referencia inmediata a ginecoobstetricia:** salida de líquido (RPM), contracciones antes de la semana 37, sangrado o fiebre en la embarazada.[2]

- **Referencia al segundo nivel:** VIH, VDRL positivo y cuello alterado que persiste tras el tratamiento.[2,3]

10. La consulta prenatal en la estación

10.1 Estudios

El criterio 8 se pierde si falta el **exudado vaginal**; los demás son los del control prenatal:[1,2,6]

- **Exudado vaginal con frotis y cultivo:** identifica el agente.
- **Biometría hemática:** anemia (en el segundo trimestre, hemoglobina menor de 10,5 g/dL).
- **Química sanguínea, grupo y Rh:** en la Rh negativo, Coombs indirecto e inmunoglobulina anti-D a las 28 semanas si no está sensibilizada.
- **Examen general de orina y urocultivo:** bacteriuria asintomática, que predispone a pielonefritis y parto pretérmino.
- **VDRL y VIH:** cribado de sífilis y VIH.
- **Curva de tolerancia a la glucosa:** entre las semanas 24 y 28; con 75 g, basta un valor igual o mayor que 92 mg/dL en ayuno, 180 a la hora o 153 a las 2 horas.
- **Proteinuria con tira reactiva:** en cada consulta.

10.2 Ecografías e indicaciones

La NOM-007 promueve una ecografía por trimestre: de **11 a 13,6 semanas** (vitalidad, edad gestacional por longitud cráneo-caudal, número de fetos y aneuploidías), de **18 a 22 semanas** (estructural) y de **29 a 30 semanas o más** (placenta, peso fetal y líquido amniótico).[1,6] En la misma consulta se indican hierro (30 a 60 mg) con ácido fólico (0,4 mg) al día, las vacunas (toxoide tetánico y diftérico, Tdpa e influenza en temporada) y la siguiente cita, con revisión de la respuesta al tratamiento.[6,20,21]

11. Casos clínicos para practicar

Se ensayan en voz alta en el orden de la sección 1.3.

Caso 1. Flujo espumoso a las 22 semanas (rúbrica)

Planteamiento. Mujer de 26 años, embarazada, que acude el 7 de noviembre de 2023. “Ciclos de 28 por 5; G2 P1; pareja nueva desde hace 6 meses, sin preservativo; FUM el 1 de junio de 2023. Flujo amarillo-verdoso, abundante y fétido desde hace 10 días, con prurito, disuria y dispareunia; sin salida de líquido, sangrado ni contracciones. Presión

de 110/70 mmHg, temperatura de 36,7 °C, glucosa capilar de 92 mg/dL. Fondo uterino en el ombligo; frecuencia cardiaca fetal de 144. Flujo espumoso amarillo-verdoso; cérvix en fresa; orificio cerrado. pH de 6,0; tricomonas móviles."

Respuesta esperada:

1. **Cálculo:** FPP del 7 de marzo de 2024 (8 de marzo por Naegele); 22 semanas y 5 días.
2. **Factores de riesgo:** pareja nueva, sin preservativo y embarazo.
3. **Diagnóstico:** embarazo de 22.5 SDG con cervicovaginitis por *Trichomonas vaginalis*; no es una RPM.
4. **Estudios:** exudado vaginal, VIH, VDRL y el resto del control prenatal; las tres ecografías.
5. **Tratamiento:** metronidazol 500 mg oral cada 12 horas por 7 días; pareja con 2 g en dosis única; abstinencia y preservativo; revaloración antes de 3 meses. Se menciona el esquema vaginal de la rúbrica y por qué ya no se usa.
6. **Riesgos:** parto pretérmino, RPM, bajo peso al nacer y mayor adquisición de VIH.

Caso 2. Olor a pescado sin embarazo

Mujer de 29 años con DIU de cobre que usa duchas vaginales, con flujo con olor a pescado y sin prurito. "Secreción grisácea homogénea; pH de 5,5; aminas positivas; células clave." **Respuesta:** VB con los cuatro criterios de Amsel. Metronidazol oral 7 días, gel 5 días o clindamicina en crema 7 días, sin alcohol; la pareja no se trata; suspender las duchas. El DIU no se retira solo por la VB.

Caso 3. Vaginosis en una embarazada con parto pretérmino previo

Mujer de 24 años con 16 semanas y un parto pretérmino previo, con flujo grisáceo y olor a pescado; pH de 5,5, aminas positivas y células clave. **Respuesta:** VB sintomática; se trata con metronidazol oral 7 días, seguro en cualquier trimestre; con alergia, clindamicina. Si no tuviera síntomas, no se buscaría ni se trataría de rutina.

Caso 4. Prurito vulvar tras un antibiótico

Mujer de 34 años sana, primer episodio de prurito intenso, disuria y flujo blanco grumoso tras tomar amoxicilina. "Eritema y edema vulvar; pH de 4,0; pseudohifas con KOH." **Respuesta:** CVV no complicada desencadenada por el antibiótico. Fluconazol 150 mg en dosis única o un azol vaginal; la pareja no se trata; los azoles tópicos pueden dañar el condón. Si no responde, examen en fresco y cultivo.

Caso 5. Candidosis de repetición con diabetes

Mujer de 45 años con diabetes mal controlada y cinco episodios en un año; glucosa capilar de 260 mg/dL; eritema extenso con fisuras y pseudohifas. **Respuesta:** CVV complicada y recurrente. Cultivo con identificación de la especie, control de la

glucemia, inducción y fluconazol semanal 6 meses, sin esquemas cortos; si es *C. glabrata*, nistatina 21 días. Referencia si no hay laboratorio.

Caso 6. Candidosis a las 30 semanas

Mujer de 31 años con 30 semanas, prurito y flujo blanco grumoso sin olor; lesiones satélite, pH de 4,0 y pseudohifas. **Respuesta:** CVV complicada por el embarazo; azol vaginal 7 días o nistatina 14 días, sin fluconazol oral; la pareja no se trata; revisar la curva de tolerancia a la glucosa. Se dice el esquema de la rúbrica y se precisa el vigente.

Caso 7. Exudado endocervical en una mujer joven

Mujer de 19 años, no embarazada, con dos parejas sin preservativo, flujo amarillento, disuria y sangrado poscoital. “Afebril; exudado endocervical mucopurulento; cuello friable; sin dolor a la movilización ni anexial; examen en fresco sin tricomonas ni células clave.” **Respuesta:** cervicitis mucopurulenta sin enfermedad inflamatoria pélvica. NAAT para *Chlamydia*, gonococo y tricomonas, sífilis y VIH; doxiciclina 7 días y ceftriaxona 500 mg intramuscular; tratar a la pareja, abstinencia y preservativo; repetir la prueba a los 3 meses.

Caso 8. Clamidia en la embarazada

Mujer de 22 años con 12 semanas y NAAT positiva para *Chlamydia*. **Respuesta:** azitromicina 1 g en dosis única (alternativa, amoxicilina 7 días), sin doxiciclina ni quinolonas; tratar a la pareja; prueba de curación a las 3 o 4 semanas y a los 3 meses; buscar gonococo, sífilis y VIH.

Caso 9. Flujo fétido sin infección aparente

Mujer de 38 años con flujo café muy fétido; a la especuloscopia, un tampón retenido. **Respuesta:** cuerpo extraño; se retira, se revisan la vagina y el cuello y vuelve si persiste el flujo. Es la razón de preguntar por cuerpos extraños en todo flujo anormal.[3]

12. Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

Se dice primero la respuesta que califica la rúbrica y se añade la vigente en la misma frase:[1,2,4,5,6,8,9]

- **Criterio 2:** FPP del 7 de marzo contando 280 días; 8 de marzo por Naegele.
- **Criterio 7:** se empieza por duchas, múltiples parejas y no usar preservativo; la lycra, las levaduras y el coito frecuente tienen respaldo débil.
- **Criterio 10:** la rúbrica habla de ecografías del tercer trimestre “cada 15 días”; la NOM-007 promueve una por trimestre.

- **Criterio 12:** la rúbrica registra metronidazol vaginal 10 noches; lo vigente es metronidazol oral 500 mg cada 12 horas por 7 días.
- **Criterio 13:** la rúbrica registra miconazol cada 12 horas 7 días o nistatina 7 días; lo vigente son azoles tópicos una vez al día 7 días o nistatina 14 días.
- **Criterio 14:** la nitrofurazona no figura en las guías revisadas.

13. Diferencias entre fuentes

La GPC de vaginitis de 2014 difiere de las guías posteriores en puntos que pueden preguntarse:[3,4,8,14,22]

- **Tricomoniasis en la mujer:** la GPC aceptaba 2 g en dosis única; los CDC y la GPC de control prenatal de 2022 indican 7 días.
- **VB asintomática en el embarazo:** la GPC la trataba; hoy no se busca ni se trata de rutina.
- **Metronidazol 2 g para la VB:** opción de la GPC que los CDC no incluyen.
- **Clamidia:** los CDC prefieren la doxiciclina fuera del embarazo.
- **Ketoconazol oral:** retirado por hepatotoxicidad.
- **Cultivo para *Chlamydia* y gonococo:** hoy la prueba de elección es la NAAT.

14. Plan de estudio de dos días

- **Día 1, mañana:** secciones 1 a 3; cálculo obstétrico con tres FUM distintas, técnica de especuloscopia y descripción de cada causa.
- **Día 1, tarde:** tabla 2, factores de riesgo y pruebas de consultorio.
- **Día 1, noche:** tabla 3 y sección 6, con los esquemas fuera y dentro del embarazo.
- **Día 2, mañana:** complicaciones, consejería y consulta prenatal (secciones 8 a 10).
- **Día 2, tarde:** los nueve casos en voz alta.
- **Día 2, noche:** Tabla 1, precisiones y diferencias; repetir las dosis y la clasificación de la CVV.

Referencias

1. [cita] Rúbricas ECOE VI. Práctica 4: Cervicovaginitis en el embarazo (16 criterios; acredita con 12). Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha.
2. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Atención y cuidados multidisciplinarios en el embarazo. GPC-IMSS-028-22. México: CENETEC; 2022. Fuente del usuario del tema 3.
3. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, diagnóstico y tratamiento de vaginitis infecciosa en mujeres en edad reproductiva en el primer nivel de atención. Guía de Referencia Rápida. México: CENETEC; 2014. Fuente del usuario del tema 4.
4. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y tratamiento de candidosis vulvovaginal en mujeres mayores a 12 años de edad. Guía de Evidencias y Recomendaciones. GPC-IMSS-609-19. México: CENETEC; 2019. Fuente del usuario del tema 4.
5. [cita] Velasco A. Reglas de apoyo en obstetricia: regla de Alfehld, regla de Johnson-Toshach, regla de McDonald y regla de Naegele. Material didáctico en PDF. Fuente del usuario del tema 3.
6. [cita] Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 2016. Fuente del usuario del tema 3.
7. [cita] Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Manual de procedimientos para la toma de la muestra de citología cervical. México: Secretaría de Salud; sin fecha (administración 2000-2006). Fuente del usuario del tema 9.
8. [cita] Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021;70(4):1-187.
9. [cita] Donders GG, Vereecken A, Bosmans E, et al. Definition of a type of abnormal vaginal flora that is distinct from bacterial vaginosis: aerobic vaginitis. BJOG. 2002;109(1):34-43.
10. [cita] Amsel R, Totten PA, Spiegel CA, et al. Nonspecific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic associations. Am J Med. 1983;74(1):14-22.
11. [cita] Reed BD. Risk factors for Candida vulvovaginitis. Obstet Gynecol Surv. 1992;47(8):551-560.
12. [cita] Foxman B. The epidemiology of vulvovaginal candidiasis: risk factors. Am J Public Health. 1990;80(3):329-331.
13. [cita] St Cyr S, Barbee L, Workowski KA, et al. Update to CDC’s treatment guidelines for gonococcal infection, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(50):1911-1916.

14. [cita] Lockwood CJ, Magriples U. Prenatal care: Initial assessment. UpToDate. Berghella V (ed). Revisión de la literatura hasta mayo de 2025. Fuente del usuario del tema 3.
15. [cita] Struthers BJ. Metronidazole appears not to be a human teratogen: review of literature. Infect Dis Obstet Gynecol. 1997;5(4):326-335.
16. [cita] Nyirjesy P, Brookhart C, Lazenby G, et al. Vulvovaginal candidiasis: a review of the evidence for the 2021 Centers for Disease Control and Prevention of Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines. Clin Infect Dis. 2022;74(Suppl 2):S162-S168.
17. [cita] The threat of aerobic vaginitis to pregnancy and neonatal morbidity. Afr J Reprod Health. 2017.
18. [cita] Masha SC, Cools P, Sanders EJ, et al. Trichomonas vaginalis and HIV infection acquisition: a systematic review and meta-analysis. Sex Transm Infect. 2019;95(1):36-42.
19. [cita] Liang Y, Chen M, Qin L, et al. A meta-analysis of the relationship between vaginal microecology, human papillomavirus infection and cervical intraepithelial neoplasia. Infect Agent Cancer. 2019;14:29.
20. [cita] World Health Organization. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: WHO; 2016.
21. [cita] Centers for Disease Control and Prevention. Prenatal care and routinely recommended vaccinations. Vaccines during pregnancy toolkit for health care professionals. 2024.
22. [cita] U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: FDA limits usage of Nizoral (ketoconazole) oral tablets due to potentially fatal liver injury and risk of drug interactions and adrenal gland problems. 26 de julio de 2013.